

Q 46 : – CAT DEVANT UNE INTOXICATION MEDICAMENTEUSE

INTRODUCTION :

- Une intoxication aiguë est un état pathologique lié à l'exposition à un toxique.
- L'intoxication peut être volontaire (**poly**-médicamenteuse+++), accidentelle.
- L'intoxication par cardiotrope est la plus grave.
- Tableau clinique dépend du mécanisme d'action du médicament.
- Urgence => PEC rapide et précoce.

DIAGNOSTIC POSITIF :

A- Interrogatoire : patient et entourage

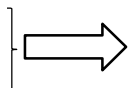
- Intoxiqué : âge, tares associées, médicaments en cours, profession (médecins...), poids.
- Toxique : nature (ordonnance, emballage...), quantité, voies d'administration (orale, IV...).
- Intoxication : heure d'ingestion et heure d'apparition des symptômes, circonstances (volontaire, accidentelle).

B- Examen clinique : l'intoxication = phénomène dynamique => 3 phases :

Phase asymptomatique

Phase d'état

Phase tardive (guérison, décès, séquelles)



Examen clinique répété

1. Recherche de signes de gravité : **troubles de conscience, DR, instabilité HD, troubles électrocardiographiques + Glycémie capillaire**

2. Examen clinique complet (neurologique, cardiovasculaire...) à la recherche de toxidrome :

Toxidromes	Signes	Toxiques
Syndrome anticholinergique	- Signes neurovégétatifs : sécheresse, soif, rétention d'urine, constipation, tachycardie. - Encéphalopathie : hallucinations, délire, mydriase, agitation, convulsions, coma.	Antidépresseurs tricycliques, antihistaminiques, antiparkinsoniens.
Syndrome sérotoninergique	- Agitation, Convulsions - Syndrome pyramidal - Tachycardie, Sueurs, Hyperthermie.	Inhibiteur de recapture de sérotonine
Syndrome adrénurgique	- Tremblements, agitation, convulsions. - HTA, palpitations, tachycardie.	Xanthines, cocaïne, amphétamine
Syndrome opioïde	- Coma calme hypotonique - Bradypnée - Myosis	Héroïne, morphiniques
Syndrome de myorelaxation	- Coma calme hypotonique, hyporéflexique. - Hypotension - Détresse respiratoire	Benzodiazépines, barbituriques, alcools
Sd d'hyperthermie maligne	- Hyperthermie - Troubles de conscience - Troubles neurovégétatifs - Hypertonie, Rhabdomyolyse	Neuroleptiques
Sd stabilisant de membrane	- Bradycardie, hypotension, choccardiogénique. - Trouble de conscience, agitation, convulsions - ECG : effet stabilisateur de membrane.	Bêta-bloquants, antiarythmiques, digitaliques
Syndrome hémorragique	Epistaxis, hématomes, hématomes...	(Éliminer une cause organique+++) Anticoagulants (AVK...)

C- Paraclinique :

1. ECG : systématique

- Troubles de rythme
- **Effet stabilisateur de membrane** : aplatissement de l'onde T, allongement QT, élargissement QRS, allongement onde P, arythmies ventriculaires
=> antidépresseurs tricycliques, cardiotropes...

2. Biologie : GDS (acidose métabolique), Glycémie, Ionogramme, CPK (rhabdomyolyse)

3. Radiographie de thorax : OAP, pneumopathie d'inhalation.

4. Toxicologie :

- Prélèvements sang, urines, liquide gastrique...
- Recherche orientée en fonction du contexte.

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL : l'intoxication est un diagnostic d'élimination → éliminer **une autre** cause.

TRAITEMENT :

A-Hospitalisation + Mise en condition : Monitoring (Fc , FR , SpO2 ..) + bilan initial

B- Traitement symptomatique : Pierre angulaire+++

Maintien des fonctions vitales (respiratoires, circulatoires, neurologiques et thermiques), toujours en premier si signes de gravité :

- Oxygénothérapie, Intubation-ventilation si coma, convulsions répétées, DR sévère ou collapsus cardiovasculaire.
- Remplissage vasculaire (500-1000ml SS9%), drogues vasoactives si **instabilité** hémodynamique **persistante**.
- Anticonvulsivants si convulsions (Diazépam 0,5mg/kg (<20kg), 10 mg (>20Kg)).
- Bicarbonate de sodium molaire si effet stabilisateur de membrane.
- Apports hydroélectrolytiques : sérum glucosé si hypoglycémie, restriction hydrique si OAP...

C- Traitement évacuateur : Toujours après le traitement symptomatique+++

1. Lavage gastrique :

- Précoce (idéalement <1h mais peut se faire jusqu'à 6h)
- **Méthode** : 1L puis aspirer, répéter jusqu'à 10L (enfant 100ml/kg) d'eau tiède + 4g NaCl ou utiliser SS.
- **Indications** : intoxications graves (quel que soit délai), doses massives, toxiques retardant vidange gastrique(tricycliques+++), médicaments LP, délai d'ingestion inconnu.
- **Contre-indications** : caustiques, moussants ou pétroliers, coma (intubation-ventilation préalable).

2. Charbon activé :

- **Posologie** : 25-50g/6h (1g/kg chez l'enfant) pendant 24h.
- **Indications** : produits carbo-adsorbables (digoxine, théophylline...)
- **Contre-indications** : troubles de conscience, obstruction intestinale, toxiques non carbo-adsorbables (lithium...).

3. Epuration :

- **Diurèse alcaline** (perfusion de bicarbonate) : barbituriques, salicylés...
- **Hémodialyse** : à visée toxicologique (éthylène glycol, méthanol) ou anurie.

D- Traitement spécifique :

Toxique	Antidote
AVK	Vitamine K
Paracétamol	N-acétyl-cystéine
Opiacés	Naloxone
Benzodiazépine	Flumazénil
Bêta-bloquant	Glucagon
Inhibiteurs calciques	Insuline

E- PEC psychiatrique (tentative de suicide).

F- Surveillance : des constantes, examen clinique, GDS.

CONCLUSION :

- La prise en charge des intoxications aiguës est bien codifiée.
- Cependant, chaque intoxication justifie une PEC spécifique tenant compte du toxique, du toxiqué et de la gravité.
- Intérêt du traitement symptomatique+++